SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Hoạt động của hệ thống quản lý điều dưỡng

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNT ngày / /2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân)

Mã: QC-C6.1 · Lần ban hành: 01

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Quy chế quy định tổ chức, nhiệm vụ, phân cấp quản lý, chế độ họp, giám sát, báo cáo và cải tiến của hệ thống quản lý điều dưỡng; áp dụng cho Phòng Điều dưỡng, Hội đồng Điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, mạng lưới điều dưỡng và người hành nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện.

Điều 2. Cơ cấu hệ thống

Cấp	Thành phần	Vai trò chính
Bệnh viện	Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc phụ trách); Phòng Điều dưỡng; Trưởng phòng Điều dưỡng (điều dưỡng trưởng bệnh viện)	Chỉ đạo, ban hành văn bản, kế hoạch; quản lý chất lượng chăm sóc toàn viện
Tư vấn	Hội đồng Điều dưỡng (Chủ tịch là lãnh đạo bệnh viện hoặc Trưởng phòng Điều dưỡng theo quyết định thành lập)	Tư vấn chuyên môn, thông qua quy trình, đánh giá kết quả, đề xuất cải tiến
Khoa	Điều dưỡng trưởng 19 khoa; điều dưỡng trưởng tua (nếu có)	Tổ chức, phân công, giám sát chăm sóc tại khoa
Mạng lưới	Mỗi khoa 01 điều dưỡng mạng lưới (chất lượng, an toàn người bệnh, KSNK)	Giám sát chéo, thu thập số liệu, lan tỏa cải tiến

Ghi chú: *Thành phần, chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng theo quyết định thành lập hiện hành của bệnh viện và Thông tư số 31/2021/TT-BYT (Cần xác minh nguyên văn).*

Chương II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Điều 3. Phòng Điều dưỡng

- Xây dựng kế hoạch hoạt động điều dưỡng năm, quý, tháng; trình Giám đốc phê duyệt.
- Xây dựng, rà soát quy định, quy trình chăm sóc; quản lý danh mục SOP điều dưỡng trên phần mềm NT Nursing.

- Giám sát chăm sóc người bệnh, đi buồng các khoa tối thiểu 01 lượt/khoa/tháng; tổng hợp chỉ số chất lượng điều dưỡng hằng tháng.
- Phối hợp Phòng Quản lý chất lượng phân tích sự cố liên quan chăm sóc theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT.
- Lập kế hoạch đào tạo liên tục, đánh giá năng lực điều dưỡng hằng năm; tổ chức thi tay nghề.
- Đề xuất bố trí nhân lực điều dưỡng theo khối lượng công việc và cấp chăm sóc.

Điều 4. Hội đồng Điều dưỡng

- Họp định kỳ 06 tháng một lần và đột xuất khi cần; có biên bản, kết luận, phân công thực hiện.
- Thẩm định quy trình chăm sóc, biểu mẫu trước khi trình ban hành; thông qua mục tiêu chỉ số chất lượng điều dưỡng.
- Đánh giá kết quả giám sát, chỉ số, đề án cải tiến; đề xuất khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt.

Điều 5. Điều dưỡng trưởng khoa

- Phân công điều dưỡng theo cấp chăm sóc; bảo đảm chăm sóc liên tục 24 giờ.
- Đi buồng hằng ngày; kiểm tra người bệnh Cấp I, người bệnh nguy cơ cao; kiểm tra hồ sơ chăm sóc tối thiểu 05 hồ sơ/tuần.
- Giám sát bàn giao ca bằng BM-C6.1-01 tối thiểu 03 lượt/tháng; xử lý ban đầu và báo cáo sự cố điều dưỡng.
- Gửi số liệu chỉ số tháng về Phòng Điều dưỡng trước ngày 05 tháng sau; tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại khoa.

Điều 6. Điều dưỡng mạng lưới

- Tham gia giám sát chéo theo phân công của Phòng Điều dưỡng; thu thập số liệu chỉ số tại khoa.
- Hướng dẫn đồng nghiệp áp dụng quy trình mới; báo cáo khó khăn, đề xuất cải tiến.

Chương III. CHẾ ĐỘ HỌP, GIÁM SÁT, BÁO CÁO

Điều 7. Chế độ họp

Cuộc họp	Tần suất	Chủ trì	Hồ sơ
Giao ban điều dưỡng trưởng	Hằng tuần	Trưởng phòng Điều dưỡng	Sổ giao ban; NT Nursing (Họp ĐDT)
Họp điều dưỡng trưởng tháng (chuyên đề chất lượng)	Hằng tháng	Trưởng phòng Điều dưỡng	BM-C6.1-02
Hội đồng Điều dưỡng	06 tháng/lần	Chủ tịch Hội đồng	Biên bản; NT Nursing (Họp HĐĐD)
Họp Hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp viện	Theo quy định của bệnh viện	Trưởng khoa / lãnh đạo bệnh viện	Biên bản; NT Nursing

Điều 8. Giám sát

Phòng Điều dưỡng ban hành kế hoạch giám sát năm (hồ sơ chăm sóc, bàn giao ca, phòng ngừa té ngã, xác định người bệnh, tuân thủ quy trình kỹ thuật, đi buồng). Kết quả giám sát được ghi trên phần mềm NT Nursing và phản hồi cho khoa trong 07 ngày làm việc.

Điều 9. Chỉ số và báo cáo

Hệ thống theo dõi bộ chỉ số KPI-C6.1-01 đến KPI-C6.1-08 theo từng khoa, từng tháng trên phần mềm NT Nursing. Phòng Điều dưỡng báo cáo Giám đốc hằng tháng; báo cáo Hội đồng Điều dưỡng 06 tháng; báo cáo năm kèm đánh giá xu hướng và kế hoạch cải tiến.

Điều 10. Cải tiến

Chỉ số không đạt mục tiêu 02 tháng liên tiếp: khoa phân tích nguyên nhân, lập kế hoạch khắc phục (nội dung, người phụ trách, thời hạn, chỉ số theo dõi); Phòng Điều dưỡng kiểm tra lại sau tối đa 01 tháng. Mỗi năm có ít nhất 01 đề án cải tiến chất lượng chăm sóc cấp bệnh viện.

Chương IV. ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Điều 11. Đào tạo và đánh giá năng lực

- Đào tạo liên tục theo kế hoạch năm (điều dưỡng mới, chuyên khoa, an toàn người bệnh, giao tiếp ứng xử).
- Đánh giá năng lực mỗi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên ít nhất 01 lần/năm bằng BM-C6.1-03; kết quả ghi vào hồ sơ nhân sự trên NT Nursing.
- Điều dưỡng mới: kèm cặp, đánh giá năng lực trước khi được phân công độc lập.

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lực

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Điều dưỡng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp vướng mắc trình Giám đốc sửa đổi, bổ sung.

GIÁM ĐỐC